Procedimentos Ambulatoriais do SUS: Análise Quantitativa do Volume de Atendimentos e Gastos Públicos (2024 – 2025)

Cristiano A. Barbosa

[1]Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB)

analytics.barbosa@gmail.com

Resumo. *O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, fundamentado na universalidade e integralidade, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo, exigindo um colossal esforço fiscal e operacional. Este artigo propõe-se a realizar uma análise quantitativa do desempenho dos* ***Procedimentos Ambulatoriais*** *do SUS, examinando o volume de atendimentos e os gastos públicos associados no período de* ***2024 a 2025****. Utilizando* ***Estatística Descritiva*** *e* ***análise de séries temporais****, o estudo mensurou os dados anuais, regionais e mensais, com foco na identificação de* ***padrões de sazonalidade*** *e* ***disparidades geográficas****. Os resultados revelam uma* ***concentração operacional massiva*** *na Região Sudeste, responsável por quase* 50% *dos atendimentos, reflexo direto de sua densidade populacional e capacidade instalada. Foi identificada uma* ***sazonalidade clara****, com picos de volume de atendimentos em* ***Maio*** *e picos de gasto em* ***Outubro****, e baixas acentuadas em* ***Janeiro/Fevereiro****. Adicionalmente, o estudo constatou uma* ***queda significativa e consistente*** *de* $31,6\%$ *tanto no volume total de atendimentos quanto no valor dos procedimentos entre 2024 e 2025, um alerta gerencial que merece investigação. Conclui-se que o planejamento orçamentário e operacional do SUS deve priorizar a mitigação das disparidades geográficas e a gestão das tendências sazonais, sendo essencial para garantir a equidade e a sustentabilidade do sistema.*

1. Introdução

O **Sistema Único de Saúde (SUS)**[1] é, por design e abrangência, um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do planeta. Fundamentado no princípio constitucional da **universalidade** e da **integralidade**, ele garante acesso gratuito a serviços essenciais para todos os mais de 200 milhões de brasileiros, desde a atenção básica e vacinação até transplantes de alta complexidade. Esta promessa monumental, contudo, é sustentada por uma estrutura financeira e operacional de escala igualmente gigantesca, que desafia a gestão pública do país.

O debate público sobre o SUS tende a focar em suas crises e desafios, obscurecendo a magnitude dos recursos aplicados e o volume impressionante de serviços entregues. Anualmente, o sistema move centenas de bilhões de Reais, provenientes da **União, Estados e Municípios**, em um esforço fiscal que garante o funcionamento de uma rede assistencial que realiza cerca de **2,8 bilhões de atendimentos por ano**.

Este artigo se propõe a analisar o SUS sob a frieza dos números, quantificando sua real dimensão. Iremos examinar os gastos anuais consolidados, essenciais para sustentar

[1]https://www.gov.br/saude/pt-br/sus

a infraestrutura nacional de saúde, e o volume de atendimentos realizado mensal e anualmente. Além de apresentar os valores absolutos, o artigo explorará a sazonalidade dessas métricas — desde as flutuações orçamentárias de final de ano que influenciam os gastos, até os picos de demanda por atendimentos causados pelas variações climáticas e epidemiológicas. O objetivo é oferecer uma perspectiva clara sobre o investimento necessário e a demanda operacional para manter o princípio fundamental da saúde como um direito universal. Google e Gemini [2025b]

Objetivo Geral

Analisar quantitativamente o desempenho operacional e o esforço fiscal do **Sistema Único de Saúde (SUS)** no que diz respeito aos **Procedimentos Ambulatoriais**, quantificando o volume de atendimentos e os gastos públicos associados no período de **2024 a 2025**.

1.1. Objetivos Específicos

- **Examinar e Quantificar:** Examinar os gastos anuais consolidados (União, Estados e Municípios) destinados aos Procedimentos Ambulatoriais do SUS no período de 2024 a 2025.
- **Mensurar o Volume:** Mensurar o volume de atendimentos ambulatoriais realizados pelo SUS em bases mensal e anual para o período estudado.
- **Identificar Sazonalidade (Gastos):** Analisar a sazonalidade e as flutuações orçamentárias de final de ano que influenciam o padrão de gastos com procedimentos ambulatoriais.
- **Identificar Sazonalidade (Demanda):** Identificar a sazonalidade da demanda por atendimentos ambulatoriais, correlacionando-a com possíveis variações climáticas e epidemiológicas.
- **Oferecer Perspectiva:** Oferecer uma perspectiva clara sobre o investimento necessário e a demanda operacional para sustentar a universalidade da saúde no contexto dos procedimentos ambulatoriais do SUS.

2. Fundamentação Teórica

Em sistemas complexos como o **Sistema Único de Saúde (SUS)**[2], a Estatística Descritiva transcende a simples sumarização de dados, constituindo-se uma ferramenta indispensável para o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e alocação de recursos Costa e Silva [2019]. A quantificação precisa do volume de atendimentos ambulatoriais e a análise do esforço fiscal (gastos públicos) são exercícios primários de estatística aplicada, que permitem aos gestores dimensionar a demanda real e otimizar a distribuição de recursos entre as esferas governamentais (União, Estados e Municípios).

[2] https://www.gov.br/saude/pt-br/sus

3. Análise Descritiva dos Atendimentos Ambulatoriais por Região

A **(Figura 1)**, apresenta a análise descritiva dos atendimentos ambulatoriais consolidados e distribuídos por Região nos anos de **2024** e **2025**. O foco da análise recai sobre as métricas de **Quantidade de atendimentos** e **Valor dos procedimentos** (em Reais).

Análise dos Atendimentos Ambulatoriais (Região)

Ano (Atendimento)	Região	Quantidade de atendimentos	Valor dos procedimentos
Total		**8.278.117.707**	**54.153.311.181,85**
Subtotal: 2024		**4.914.747.779**	**32.194.102.317,26**
2024	Centro-Oeste	358.745.387	2.370.889.934,18
	Nordeste	966.227.118	7.846.063.629,75
	Norte	291.642.923	2.164.297.435,40
	Sudeste	2.505.018.940	14.814.497.128,22
	Sul	793.113.411	4.998.354.189,71
Subtotal: 2025		**3.363.369.928**	**21.959.208.864,59**
2025	Centro-Oeste	245.101.103	1.626.896.862,06
	Nordeste	641.005.780	5.175.521.227,60
	Norte	194.022.085	1.496.181.298,98
	Sudeste	1.718.849.114	10.114.448.164,35
	Sul	564.391.846	3.546.161.311,60

Figura 1. Atendimentos Ambulatoriais (Região) 2024 - 2025

A principal causa para a Região Sudeste ser responsável por mais de 50% do total de atendimentos ambulatoriais do SUS é a sua alta densidade populacional e econômica, que se traduz em maior demanda e maior capacidade instalada do sistema de saúde.

População Absoluta: A **Região Sudeste** (**São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro** e **Espírito Santo**) é a mais populosa do Brasil. Em **2024**, a população estimada é superior a **90 milhões** de habitantes, representando cerca de **41%** da população total do país. Naturalmente, esta concentração populacional gera uma demanda absoluta significativamente maior por serviços de saúde, incluindo atendimentos ambulatoriais. Google e Gemini [2025a]

4. Análise Descritiva dos Atendimentos Ambulatoriais por Unidade da Federação (2024)

A **(Figura 2)**, apresenta o panorama descritivo dos atendimentos ambulatoriais consolidados por **Unidade da Federação (UF)** para o ano de **2024**, detalhando a **Quantidade de Atendimentos** e o **Valor dos Procedimentos** correspondentes.

2024

Análise dos Atendimentos Ambulatoriais (Unidade da Federação)

Ano (Atendimento)	Unidade da Federação	Quantidade de atendimentos	Valor dos procedimentos
Total		**4.914.747.779**	**32.194.102.317,26**
Subtotal: 2024		**4.914.747.779**	**32.194.102.317,26**
	Acre	17.186.046	125.389.104,20
	Alagoas	57.291.493	466.692.542,58
	Amapá	13.424.326	123.833.571,95
	Amazonas	68.146.386	494.577.388,00
	Bahia	233.239.548	2.128.781.612,38
	Ceará	160.693.356	1.079.250.131,41
	Distrito Federal	60.174.606	401.691.478,17
	Espírito Santo	102.349.566	670.145.135,46
	Goiás	167.750.286	1.130.222.552,16
	Maranhão	121.665.983	908.106.257,58
	Mato Grosso	75.504.746	471.765.282,32
	Mato Grosso do Sul	55.315.749	367.210.641,53
	Minas Gerais	424.967.090	3.118.109.341,98
2024	Pará	121.930.846	876.291.892,33
	Paraíba	82.455.967	609.772.604,63
	Paraná	361.972.685	1.904.375.374,80
	Pernambuco	175.925.802	1.407.221.195,77
	Piauí	39.503.559	449.320.802,48
	Rio de Janeiro	494.344.122	3.155.881.547,15
	Rio Grande do Norte	64.140.062	514.026.996,34
	Rio Grande do Sul	197.633.206	1.720.787.315,79
	Rondônia	39.602.262	299.328.902,74
	Roraima	7.998.029	74.038.997,37
	Santa Catarina	233.507.520	1.373.191.499,12
	São Paulo	1.483.358.162	7.870.361.103,63
	Sergipe	31.311.348	282.891.486,58
	Tocantins	23.355.028	170.837.578,81

Figura 2. Atendimentos Ambulatoriais por Unidade da Federação (2024)

O sistema ambulatorial está massivamente concentrado no Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais sendo responsáveis pela maioria absoluta dos atendimentos e despesas.

A distribuição de atendimentos em **2024** de acordo com a (**Figura 2**), revela uma alta concentração operacional e fiscal do SUS. Em conjunto, as três maiores Unidades da Federação (UF) em volume absoluto – **São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais** – respondem por mais de $\mathbf{48,88}\%$ (quase metade) de todos os atendimentos ambulatoriais registrados no país. Este dado não apenas espelha a concentração demográfica histórica na **Região Sudeste**, mas também sublinha a dependência do sistema de saúde em relação à robustez da infraestrutura instalada nesses poucos estados.

5. Análise Descritiva dos Atendimentos Ambulatoriais (Unidade da Federação) - 2025

A **(Figura 3)**, detalha os dados consolidados de atendimentos ambulatoriais por **Unidade da Federação (UF)** para o ano de **2025**. A análise abrange as métricas de **Quantidade de Atendimentos** e o **Valor dos Procedimentos** (em Reais).

2025

Análise dos Atendimentos Ambulatoriais (Unidade da Federação)

Ano (Atendimento)	Unidade da Federação	Quantidade de atendimentos	Valor dos procedimentos
Total		**3.363.369.928**	**21.959.208.864,59**
Subtotal: 2025		**3.363.369.928**	**21.959.208.864,59**
	Acre	12.661.112	92.142.528,43
	Alagoas	35.115.762	311.073.381,23
	Amapá	9.486.066	91.560.675,66
	Amazonas	43.128.865	333.727.198,85
	Bahia	157.153.419	1.420.062.464,89
	Ceará	117.345.174	759.471.289,60
	Distrito Federal	43.144.906	279.998.261,22
	Espírito Santo	70.268.462	454.285.965,87
	Goiás	115.728.643	772.031.916,95
	Maranhão	74.854.402	581.965.004,08
	Mato Grosso	50.673.179	334.117.552,10
	Mato Grosso do Sul	35.554.375	240.749.131,79
	Minas Gerais	299.322.582	2.232.891.739,86
2025	Pará	82.527.279	611.631.811,51
	Paraíba	51.938.510	408.035.881,46
	Paraná	259.586.868	1.387.116.409,64
	Pernambuco	109.218.475	870.434.753,63
	Piauí	27.200.063	291.230.967,63
	Rio de Janeiro	300.080.227	1.885.820.192,15
	Rio Grande do Norte	44.076.408	344.640.978,71
	Rio Grande do Sul	139.583.161	1.202.702.374,71
	Rondônia	24.990.276	204.656.526,88
	Roraima	4.856.858	47.530.841,54
	Santa Catarina	165.221.817	956.342.527,25
	São Paulo	1.049.177.843	5.541.450.266,47
	Sergipe	24.103.567	188.606.506,37
	Tocantins	16.371.629	114.931.716,11

Figura 3. Atendimentos Ambulatoriais por Unidade da Federação (2025)

A comparação entre os dados de atendimentos ambulatoriais de 2024 e 2025 revela uma queda significativa tanto no volume total de atendimentos quanto no valor total dos procedimentos no período analisado.

Entre **2024 e 2025**, o sistema nacional de atendimentos ambulatoriais experimentou uma queda de $\mathbf{31,57\%}$ no volume total de atendimentos (de $\mathbf{4,91}$ **bilhões** para $\mathbf{3,36}$ **bilhões**) e uma redução de $\mathbf{31,80\%}$ no valor total dos procedimentos (de $\mathbf{R\$32,19}$ **bilhões** para $\mathbf{R\$21,95}$ **bilhões**).

Esta consistência na queda, com a variação percentual do custo praticamente idêntica à do volume, sugere que a principal causa da retração é uma diminuição na quantidade de eventos registrados ou realizados, e não uma mudança na complexidade (custo médio) dos procedimentos.

6. Análise Descritiva da Receita Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais (2024)

A **(Figura 4)**, apresenta a série temporal da receita mensal (dispêndios) dos Procedimentos Ambulatoriais no Brasil para o ano de **2024**, ilustrando o ciclo sazonal e a polarização regional nos gastos.

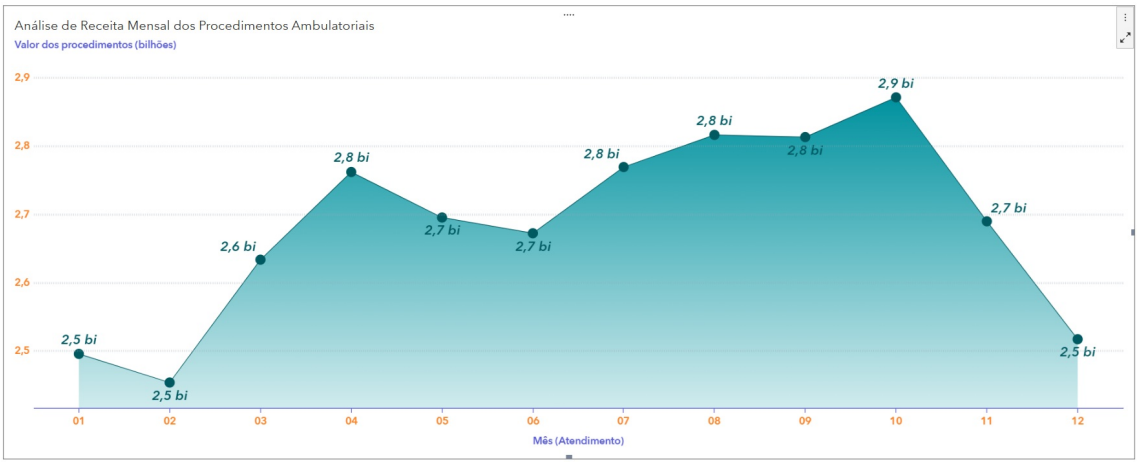

Figura 4. Análise Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais (2024)

A receita mensal dos procedimentos ambulatoriais em 2024 demonstra uma sazonalidade bem definida, refletindo os ciclos operacionais e de faturamento do sistema de saúde ao longo do ano.

O **Padrão Sazonal** da receita mensal dos procedimentos ambulatoriais em 2024 é bem definido, refletindo ciclos operacionais e de faturamento ao longo do ano. O **Ponto Mínimo** da receita foi registrado em **Fevereiro (Mês 02)**, alcançando $\mathbf{R\$2,5}$ **bilhões**, o que está frequentemente associado ao **menor número de dias úteis**, impactando a capacidade de realização e faturamento dos procedimentos.

Seguiu-se um **Crescimento no Primeiro Semestre** com uma recuperação significativa, atingindo um pico intermediário de $\mathbf{R\$2,8}$ **bilhões** em **Abril (Mês 04)**. O **Pico Anual** de gastos foi observado em **Outubro (Mês 10)**, com $\mathbf{R\$2,9}$ **bilhões**, refletindo a tendência histórica do quarto trimestre de apresentar maior volume de despesas devido a fatores orçamentários ou fechamento de contas. Por fim, houve uma **Queda de Final de Ano**, com o valor caindo para $\mathbf{R\$2,7}$ **bilhões em Novembro** e atingindo novamente o patamar de $\mathbf{R\$2,5}$ **bilhões** em **Dezembro (Mês 12)**, redução comumente ligada a feriados, férias coletivas e interrupções nas atividades de faturamento.

7. Análise Descritiva da Receita Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais (2025)

A (**Figura 5**), ilustra a série temporal da Receita Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais, cobrindo os primeiros oito meses do período de **2025** (**Janeiro a Agosto**).

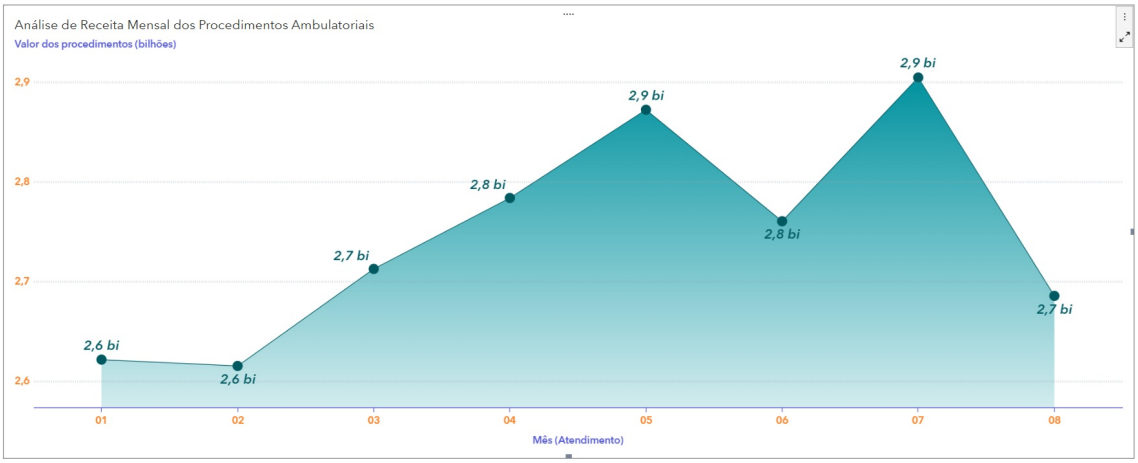

Figura 5. Análise Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais (2025)

A Receita Mensal dos Procedimentos Ambulatoriais (Meses de Janeiro a Agosto de 2025) revela um cenário de crescimento líquido, porém marcado por instabilidade na segunda metade do período.

O ano de 2025 iniciou com uma receita estável de $\mathbf{R\$2,6}$ **bilhões** nos meses de **janeiro e fevereiro**. A partir de março, o setor demonstrou forte dinamismo, com um crescimento progressivo de $\mathbf{R\$0,1}$ **bilhão** a cada mês, alcançando o primeiro pico de $\mathbf{R\$2,9}$ **bilhões** em maio. Após uma breve queda em junho, a receita se recuperou totalmente, igualando o valor recorde em julho, antes de enfrentar a maior retração do período.

A dinâmica observada na receita mensal dos procedimentos ambulatoriais em 2025 pode ser explicada por três fatores principais: o **Efeito Pós-Férias e Retomada Eletiva**, **Campanhas de Saúde e Prevenção**, e **Ajustes Contratuais e Regulatórios**. O aumento consistente a partir de março reflete a retomada da demanda por exames e consultas que foram adiadas durante o período de **férias e feriados de final e início de ano.** Os picos em **maio e julho** frequentemente coincidem com períodos de intensificação de campanhas de saúde pública ou privada, elevando o volume de consultas de rotina e procedimentos diagnósticos. Por fim, reajustes periódicos nas tabelas de remuneração de operadoras de saúde ou a entrada em vigor de novos contratos podem ter elevado o valor médio dos procedimentos registrados, caracterizando **Ajustes Contratuais e Regulatórios**.

8. Análise Descritiva do Volume de Atendimentos Ambulatoriais (2024)

A **(Figura 6)**, apresenta a série temporal do volume mensal de atendimentos ambulatoriais para **2024**, destacando a tendência de queda observada ao longo do período analisado (Meses de Atendimento).

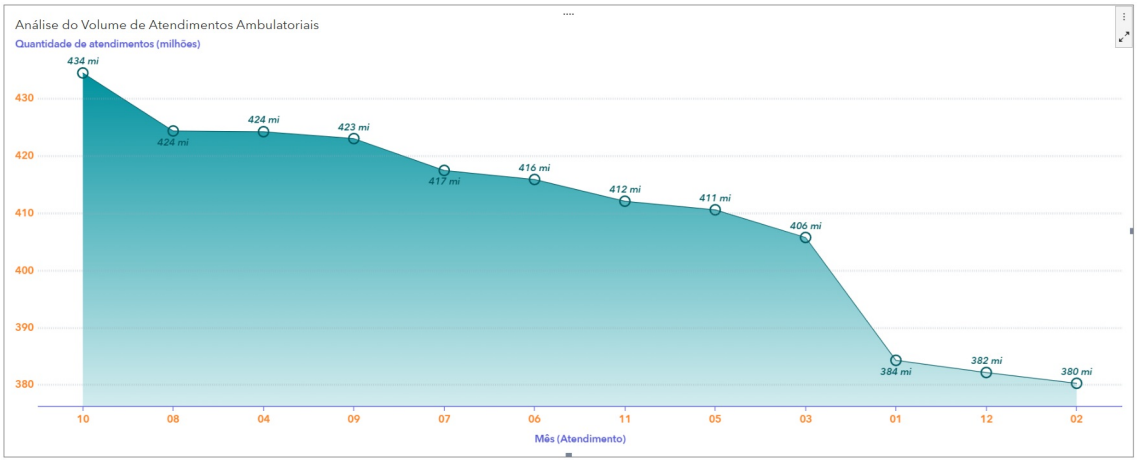

Figura 6. Análise do Volume de Atendimentos Ambulatoriais (2024)

O padrão observado é altamente compatível com a sazonalidade típica da saúde no Brasil, onde o final do ano civil registra alta e o início (Janeiro/Fevereiro) registra baixa.

O volume de atendimentos ambulatoriais exibiu um comportamento de queda substancial ao longo do período analisado, partindo de um pico de alta de **434 milhões no Mês 10 (Outubro)**. Esse pico e os volumes elevados nos meses de meio de ano (como **Mês 08, Mês 04, Mês 09, Mês 07**) são impulsionados pela sazonalidade de **doenças**, onde há maior procura no final do **outono e inverno** devido à **incidência de infecções respiratórias e condições crônicas**, além de fatores de gestão e planejamento no final do ano fiscal que motivam um esforço concentrado para cumprir metas e realizar mutirões.

A série mostra um declínio gradual, culminando na baixa mais acentuada observada entre o **Mês 03 (406 mi) e o Mês 01 (384 mi)**, atingindo a mínima de **380 milhões em Mês 02 (Fevereiro)**. Essa queda é classicamente causada pela sazonalidade do início do ano, manifestando-se em uma dupla redução: a demanda diminui **(pacientes adiam consultas devido a férias e lazer)** e a oferta se retrai **(hospitais e clínicas concedem férias coletivas)**, sendo um padrão esperado e natural no setor de saúde brasileiro, o que confirma a tendência de baixa no volume total de atendimentos (eletivos) no período de **janeiro e fevereiro**.

9. Análise Descritiva do Volume de Atendimentos Ambulatoriais (2025)

A **(Figura 7)**, apresenta a distribuição do volume mensal de atendimentos ambulatoriais para o ano de **2025**, evidenciando uma clara tendência geral de declínio ao longo do período representado (Meses de Atendimento).

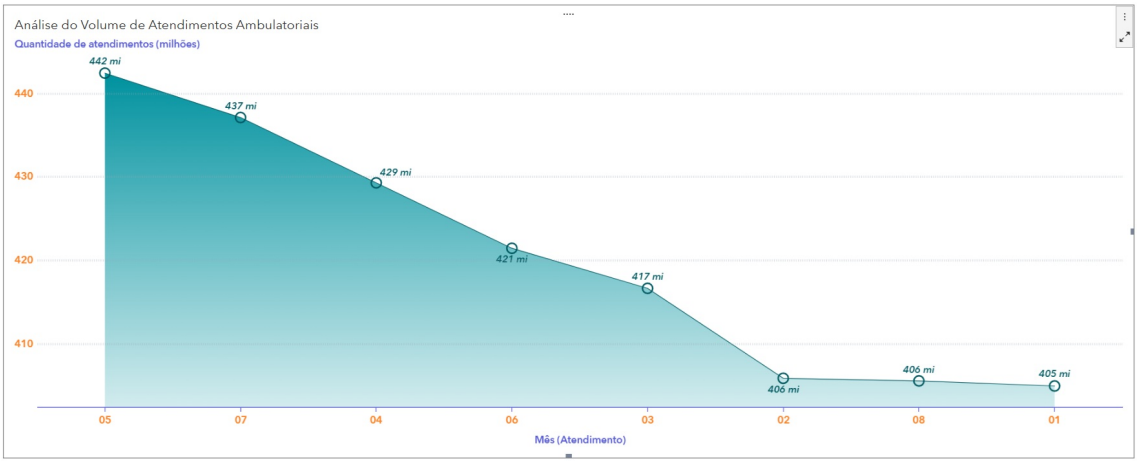

Figura 7. Análise do Volume de Atendimentos Ambulatoriais (2025)

A série de 2025 revela um pico de 442 milhões em Maio, impulsionado pela sazonalidade de doenças, seguido por uma tendência geral de queda.

A análise do volume de atendimentos ambulatoriais de **2025** mostra um comportamento sazonal clássico, com uma tendência geral de queda após o meio do ano. O pico de **442 milhões em Maio (Mês 05)**, e volumes altos subsequentes, é impulsionado por doenças sazonais **(outono/inverno)** e maior procura por serviços. A série culmina em uma baixa acentuada entre **Março (417 mi) e Fevereiro (406 mi)**, atingindo a mínima de **405 milhões em Janeiro (Mês 01)**. Essa baixa é o resultado da sazonalidade de início de ano, onde ocorre uma dupla redução: a demanda **cai devido a férias e lazer dos pacientes**, e a **oferta é reduzida por férias coletivas dos profissionais de saúde**, estabilizando o volume em um patamar mínimo.

10. Conclusão

Em suma, este estudo de **Análise Quantitativa** dos **Procedimentos Ambulatoriais do SUS (2024-2025)** cumpriu seu objetivo principal ao quantificar o volume de atendimentos e o esforço fiscal, revelando a magnitude operacional e as disparidades regionais que caracterizam o Sistema Único de Saúde. A análise consolidou que a Região Sudeste é o eixo operacional, com seus estados respondendo por quase metade ($\mathbf{48,88\%}$) de todos os atendimentos, o que aponta para uma necessidade crítica de investimento em infraestrutura e otimização de recursos nas demais regiões para garantir a integralidade e equidade do acesso. Identificou-se também uma clara sazonalidade nos ciclos de gasto e demanda, com o Pico Anual de Gastos em Outubro e o Pico de Atendimentos em Maio, impulsionados por fatores como o fechamento orçamentário e a alta procura por serviços no período de **outono/inverno** devido a doenças sazonais. Por outro lado, a Baixa de **Janeiro/Fevereiro** é um padrão recorrente que exige ações gerenciais para mitigar a retração na oferta e na demanda. Por fim, a observação de uma queda consistente e significativa de $\mathbf{31,6\%}$ no volume total de atendimentos e no valor dos procedimentos entre **2024 e 2025** acende um alerta gerencial, sugerindo uma retração na capacidade de registro ou na oferta de serviços que merece investigação aprofundada. O SUS, em sua escala monumental, exige que o planejamento de recursos transcenda o monitoramento de totais, focando nas tendências sazonais e na mitigação das disparidades geográficas, sendo essencial que futuras pesquisas se concentrem na correlação direta entre investimentos e a densidade de serviços ofertados para embasar políticas públicas de saúde com maior equidade.

Referências

Costa, N. R. and Silva, E. D. (2019). *Estatística Aplicada à Gestão em Saúde*. Editora Científica, Rio de Janeiro.

Google and Gemini (2025a). Análise populacional e concentração de atendimentos ambulatoriais na região sudeste. Plataforma Web Gemini.

Google and Gemini (2025b). Definição do sistema Único de saúde (sus). Plataforma Web Gemini.